·专家共识·

流动人口麻风病例管理专家共识

广东省麻风病防治专家组

[摘要] 麻风病是重要的公共卫生问题,在流动人口中造成了严重的疾病和经济负担,然而目前我省尚未有统一的流动人口麻风病例管理流程方案。我们通过探索和实践形成本流动人口麻风病例管理专家共识,主要对流动人口麻风病例发现、病例管理、机构职责、质量控制等方面进行详细说明。根据病例发现时的医疗机构性质的不同:属地麻防机构/麻风病定点诊疗机构、属地其他医疗机构、非属地医疗机构,按相应职责进行病例信息收集、报病、转诊(按需)、录入专病系统、治疗、随访、康复服务等,以及必要时进行病例的迁入和迁出。本共识的制定将有助于规范流动人口麻风病例管理,降低麻风危害,切实保障人民群众身体健康,也为其他省份或地区麻风病防治工作提供借鉴和参考。

[关键词] 麻风病; 流动人口; 病例管理

Expert consensus on the management of migrant patients with leprosy

Guangdong Leprosy Control and Prevention Expert Group

Correspongding author: *WANG Xiaohua*, *E-mail*: *Wxh_21773@163.com*

[**Abstract**] Leprosy, an important public health issue, can impose serious health and economic burden on migrant population. However, there is no unified management plan for migrant patients with leprosy in Guangdong province. Through exploration and practice, we developed this consensus on the management of migrant patients with leprosy. The management plan includes the case detection and management, institutional responsibility and quality control. According to the different types of the medical institutions at the time of case diagnosed, leprosy prevention institutions where patient lives, other medical institutions where patient lives, and non-local medical institutions, the medical institutions should carry out the following measures according to the corresponding responsibility: collection of patients' information, report of the case, referral when needed, entry into the specialized disease system, treatment, follow-up, rehabilitation services, and moving in or out. The establishment of this management plan will help standardize the case management of migrant patients with leprosy, reduce the disease burden, protect the health of the people, and also provide guidance and reference for the leprosy prevention and control in other provinces or regions.

[**Keywords**] leprosy; migrant patients; case management

麻风病(leprosy)是指由麻风分支杆菌引起的一种慢性传染病,潜伏期通常为 2 ~ 5 年,主要病变在皮肤和周围神经,临床表现为麻木性皮肤损害、神经粗大、严重者甚至肢端残废[1-3]。流动人口麻风病患者是指离开户籍所在地的县、市或区,以工作、生活为目的而异地居住的麻风病患者,包含省级和省内流动[4-5]。广东省地区生产总值及流动人口总量连续多年为全国第一,2022 年末广东省常流动人口数量已达 2 607.08 万,占人口总数的 20.6%[6-7]。广东省流动人口中麻风病例占比也持续升高[8],2023 年新发非户籍麻风病例 22 例,占广东省新发麻风病例的 64.7%,占全国

DOI:10.3969/j.issn.1674 - 8468.2025.01.001

通信作者:王晓华, 主任医师,硕士生导师,E-mail:Wxh_21773@163.com

的35.5%,麻风病在流动人口中造成了严重的疾病和经济负担[9-11]。

探索和制定流动人口麻风病例管理流程,加强流动人口麻风病例的规范化管理,对于减少麻风危害、全面实现消除麻风危害目标、保障人民群众身体健康有着重要的指导意义。为此,广东省麻风病防治专家组牵头组织省内麻风防治管理、临床诊疗、疫情监测等方面专家,在国家及广东省相关政策指导下,结合广东省麻风病实践经验,共同制定本专家共识,供防治专业机构人员参考使用。

1 基本原则

1.1 全程管理原则

发现麻风病患者后,患者将被纳入《全国麻风病防治管理信息系统(management information system in China, LEPMIS)》[12]管理,包括患者治疗、密切接触者检查、迁入迁出管理、畸残康复服务、病例随访(现症随访和愈后随访)等,直至死亡。

1.2 免费治疗原则[13]

对由广东省内麻风病防治专业机构管治的麻风病患者,提供免费MDT治疗;对有麻风反应或神经炎的患者,提供部分免费药物。

1.3 保密原则

病例相关信息包括是否患病、基本信息、治疗信息等隐私实行保密原则[14],仅限患者管治地区的省级、市级及县(区)级麻风病防治机构工作人员知悉。如患者需要回原籍管治,则需提前征得患者同意再与原籍地麻风病防治管理机构进行迁出迁入事宜的联络。

2 管理流程

2.1 病例发现

2.1.1 自报 普通公众当自身出现麻风病可疑症状时,主动到麻防机构就诊或咨询麻风病,并确诊。

2.1.2 他报 由他人(非医疗卫生人员)主动向当地麻风病防治专业机构报告其发现的麻风病疑似症状者,然后由麻风防治专业人员上门核查确诊。

2.1.3 团体检查 利用职业体检、入学、人伍体检、用工体检及返乡人群体检等机会,进行麻风病疑似症状者筛查。如通过与外来人员工作单位或居住社区管理部门的合作,以健康体检或义诊等形式开展,在外来人口中筛查麻风病疑似症状者。

2.1.4 症状监测[15] 有症状监测任务数的医疗卫生机构的皮肤科、神经科及相关科室的医务人员发现、报告疑似麻风病患者或麻风病患者,并及时确诊或转诊至麻风病防治机构。

2.1.5 皮肤科就诊 没有症状监测任务数的医疗卫生机构的皮肤科医生发现、报告疑似麻风病患者或麻风病患者,并及时确诊或转诊至麻风病防治机构。

2.1.6 其他科就诊 没有症状监测任务数的医疗卫生机构的非皮肤科医生发现、报告疑似麻风病患者或麻风病患者,并及时确诊或转诊至麻风病防治机构。

2.1.7 疫点调查 在疫点调查工作中发现麻风病患者。

2.1.8 强化发现 在强化病例发现工作中发现麻风病患者。

2.1.9 接触者检查 对所有现症和愈后麻风病患者的家属、同事和邻居等密切接触人群进行的定期麻风病检查。

2.2 病例管理

流动人口中麻风病例实行属地管理,由属地的麻风病防治专业机构开展病例的治疗、随访等管治服务。根据发现病例的医疗机构不同,可以分为:属地麻防机构/麻风病定点诊疗机构发现病例、属地其他医疗机构(非麻防/非定点诊疗)发现病例、非属地医疗机构发现病例。属地其他医疗机构(非麻防/非定点诊疗)发现的麻风病例应转诊至患者属地麻防机构/麻风病定点诊疗机构进行管治,非属地医疗机构发现的麻风确诊病例应转诊至患者常住地麻防专业机构进行LEPMIS填报和后续的治疗、随访等管治工作。

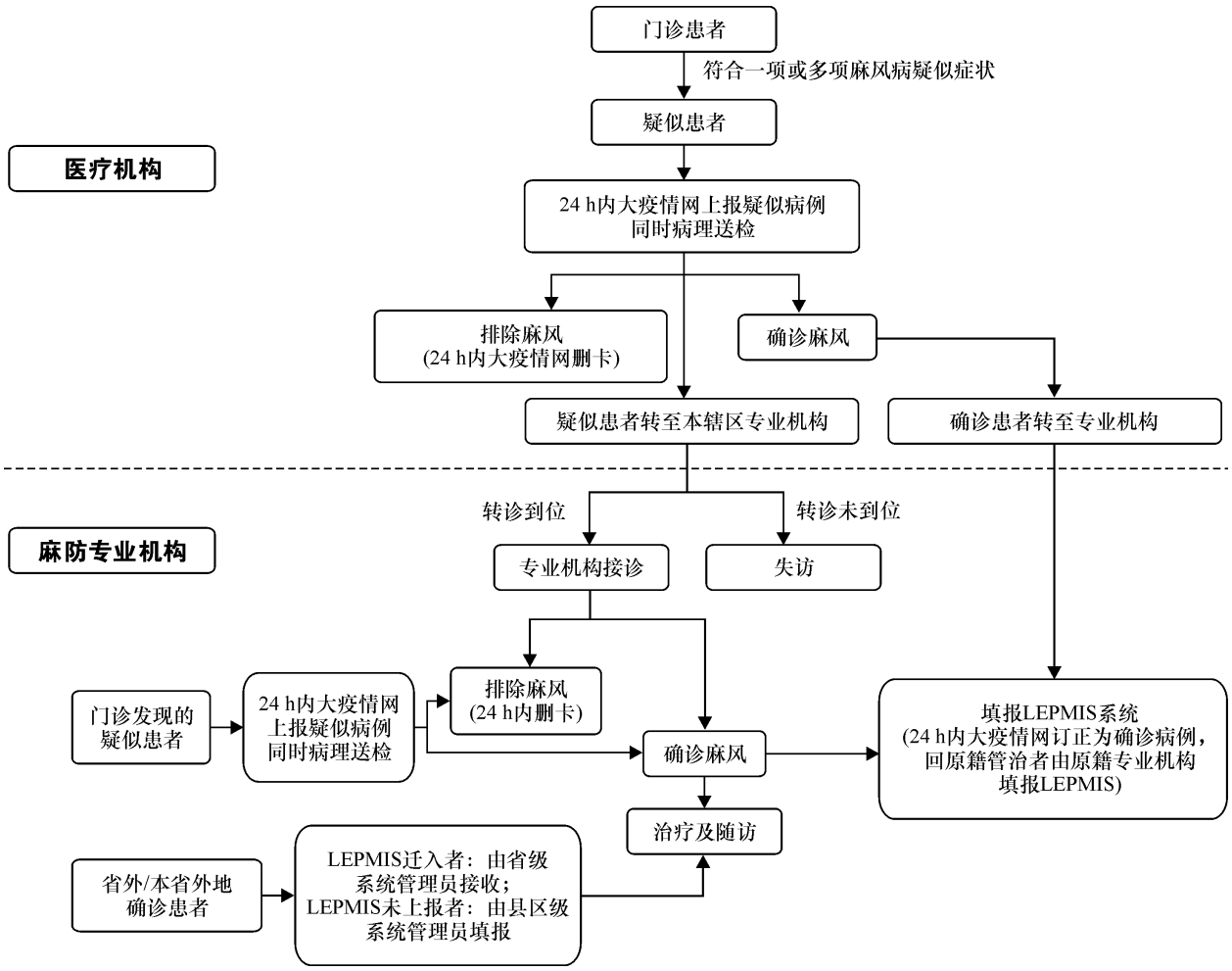
2.2.1 属地麻防机构/麻风病定点诊疗机构发现病例 属地麻防专业机构发现疑似麻风病例后,24 h内由首诊医生在《国家传染病网络直报系统》(以下简称大疫情网)报病。经本机构或上级麻风病防治专业机构进行麻风病查菌、病理检查后排除麻风病的,应24 h内在大疫情网删除疑似

病例报卡。确诊麻风病的,应 24 h 内在大疫情网订正为确诊病例,同时由本机构的 LEPMIS 系统/信息管理员在 LEPMIS 系统中填报病例详细信息,并开展后续的治疗和随访等管治工作。

2.2.2　属地其他医疗机构(非麻防/非定点诊疗)发现病例　属地其他医疗机构(非麻防)发现疑似麻风病例后,24 h 内由首诊医生在大疫情网报病。经本医疗机构、本地区或上级麻风病防治专业机构进行麻风病查菌、病理检查后排除麻风病的,应 24 h 内在大疫情网删除疑似病例报卡。确诊麻风病的,应 24 h 内在大疫情网订正为确诊病例,同时将确诊病例转诊至患者属地麻防机构/麻风病定点诊疗机构,并由当地麻风病防治专业机构的 LEPMIS 系统/信息管理员在 LEPMIS 中填报病例详细信息,并开展后续的治疗和随访等管治工作。

2.2.3　非属地医疗机构发现病例　非属地医疗机构发现疑似麻风病例后,24 h 内由首诊医生在大疫情网报病。然后可联络本地区麻防机构进行病例会诊,待排除/确诊麻风病例后应 24 h 内在大疫情网进行病例删除/订正。根据确诊病例意愿,在其知情同意基础上可选择转诊至当地或原籍地麻防机构/麻风病定点诊疗机构,负责管治的麻防专业机构应进行 LEPMIS 填报和后续的治疗、随访等管治工作。

病例整体管理流程见图 1,转诊时可参考使用的《迁入迁出联系表》见表 1。



注:无法开展病理活检的医疗机构可联系本地区综合医疗机构、上级麻风病防治专业机构进行病理检查。

图 1　流动人口麻风病例管理流程图

Figure 1　Flowchart of the case management of migrant patients with leprosy.

表 1 流动人口麻风病例管理迁入迁出联系表

Table 1 Contact list of the moving-in and moving-out cases of migrant patients with leprosy

患者姓名		性别	
年龄		联系电话	
户口地址		现住址	
身份证号		LEPMIS ID	
迁出地区		迁出麻防机构	
拟迁入地区		拟迁入麻防机构	
迁出原因		患者是否已知情同意	
迁出市级 LEPMIS 系统管理员	签字： 年 月 日		

3 麻风防治机构职责

3.1 省级麻风病防治专业机构/定点诊疗机构

省级麻风病防治专业机构负责总体流动人口麻风病例管理工作，协调全国其他省份、辖区各地市麻风病例的迁入/迁出，对辖区市、县（市、区）级麻风病防治专业机构提供技术指导和开展质量控制。

3.2 地市、县（市、区）级麻风病防治专业机构/定点诊疗机构

对首次发现的麻风病例进行大疫情网报病，并根据最终诊断情况及时（24 h 内）进行订正/删卡；接受辖区内其他医疗机构转诊的疑似麻风病例，并进行确诊；对本地区、外省/本省外地确诊麻风病例（非 LEPMIS 迁入患者）在 LEPMIS 中填报病例详细信息；对新诊断或转入的麻风病例进行治疗和随访；及时正确处理病例在治疗随访中出现的麻风反应、神经炎、药物副作用及开展畸残预防和康复；对患者的密切接触者进行监控检查。市级麻风病防治专业机构应负责辖区各县（市、区）间的病例协调工作，对辖区医疗机构、县（市、区）级麻风病防治机构提供技术指导和开展质量控制。

3.3 非麻防专业医疗机构

对首次发现的麻风病例进行大疫情网报病，并根据最终诊断情况及时（24 h 内）进行订正/删卡；无确诊能力的医疗机构应将疑似麻风病病例转诊至当地麻风病防治专业机构进行确诊；确诊的麻风病例，转诊至患者现住地麻风病防治专业机构进行后续治疗和随访等管治；协助提供疑似/确诊麻风病例相关信息。

4 质量控制

4.1 机构职责

省级麻风病防治专业机构统筹安排开展全省流动人口麻风病例管理工作，地市级、县区级麻风病防治专业机构负责本辖区内流动人口麻风病例管理工作的具体实施、技术指导和质量控制。

4.2 培训和技术指导

省级麻风病防治专业机构制订管理流程并开展省级技术培训，组织省级麻风病防治专家组成员进行技术指导；地市级麻风病防治专业机构每年至少应召开 1 次培训，培训人员涵盖辖区医疗机构相关人员。

4.3 督导考核

逐级开展定期和不定期相结合的工作督导，各地市、县区级麻风病防治专业机构每年应至少开展一次督导，及时发现、上报和解决相关问题。省级麻风病防治专业机构将结合年度防治工作考核对各地工作开展情况进行督导。

5 结语

根据《全面消除麻风危害可持续发展规划（2024—2030 年）》（国疾控传防发〔2024〕2 号）相关要求，各地区要加强麻风病流动患者管理，尤其是治疗管理。因此，建立完善的医防协同、检查诊治、康复随访全流程的服务管理流程和机制，探索麻风患者服务在不同地区、不同防治机构和社区之间的无缝衔接，对于流动人口麻风病例的规范管理有着至关重要的作用，也是全面实现消除麻风危害的目标，切实保障人民群众身体健康，促进社会文明进步的强有力保障。

执笔人：陈磊（南方医科大学皮肤病医院/广东省皮肤性病防治中心）

参与共识制订专家名单（按姓氏笔画排序）：王成（南方医科大学皮肤病医院/广东省皮肤性病防治中心）、王晶（佛山市疾病预防控制中心）、龙金德（云浮市慢性病防治中心）、冯光永（清远市慢性病防治医院）、朱小丹（汕尾市公共卫生中心）、朱正丹（潮州市慢性病防治中心）、刘宇伦（肇庆市皮肤病医院）、刘荣飞（佛山市疾病预防控制中心）、刘宪强（河源市慢性疾病防治院）、许小娟（阳江市公共卫生医院）、许宗严（深圳市福田区慢性病防治院）、阮弋（茂名市慢性病防治中心）、阮永明（江门市皮肤医院）、李英华（江门市皮肤医院）、邱庆龄（揭阳市慢性病防治院）、张东合（江门市疾病预防控制中心）、张奕南（中山市第二人民医院）、张森森（惠州市皮肤病医院）、陈发颖（肇庆市皮肤病医院）、陈春丽（湛江市慢性病防治所）、范妙玲（梅州市慢性病防治院）、林家凤（清远市慢性病防治医院）、罗权（广州市皮肤病防治所）、冼宇明（吴川市慢性病防治站）、钟明浩（东莞市第六人民医院）、钟雪莲（广州市皮肤病防治所）、袁嫣仪（中山市第二人民医院）、谈耿介（江门市新会区皮肤医院）、梁君（湛江市慢性病防治所）、梁媛（韶关市慢性病防治院）、曾美玲（南方医科大学皮肤病医院/广东省皮肤性病防治中心）、谢文聪（东莞市第六人民医院）、蔡于茂（深圳市慢性病防治中心）、蔡晓丹（汕头市皮肤性病防治院）、薛浩泽（深圳市慢性病防治中心）

[参考文献]

[1] 沈建平，张国成. 麻风和其他分枝杆菌感染[M]. 南京：江苏科学技术出版社，2005.

[2] 李文忠. 现代麻风病学[M]. 上海：上海科学技术出版社，2006.

[3] ALREHAILI J. Leprosy classification, clinical features, epidemiology, and host immunological responses: failure of eradication in 2023[J]. Cureus, 2023, 15(9): e44767.

[4] 张国成，严良斌，沈建平. 全国消除麻风病危害规划工作指南：2012 年版[M]. 南京：江苏科学技术出版社，2013.

[5] CHEN L, ZHENG D, LI M, et al. Epidemiology and grade 2 disability of leprosy among migrant and resident patients in Guangdong: an unignorable continued transmission of leprosy[J]. Front Public Health, 2023, 11: 1275010.

[6] QIAO G, CHEN F, WANG N, et al. Spatio-temporal evolution analysis of the coupling situation of economic-social-ecological system in Guangdong[J]. Environ Sci Pollut Res Int, 2023, 30(12): 32406 – 32426.

[7] 广东省统计局. 广东统计年鉴 2023[J/OL]. http://tjnj.gdstats.gov.cn:8080/tjnj/2023/.

[8] 曾美玲，陈磊，黎明，等. 2012—2021 年广东省麻风病流行病学特征分析[J]. 皮肤性病诊疗学杂志，2023，30(1)：78 – 82.

[9] GEORGE N, MAJEED A P, SASIDHARANPILLAI S, et al. Clinical profile of leprosy among domestic and migrant patients diagnosed at a tertiary referral centre in North *Kerala*: a ten-year retrospective data analysis[J]. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2022, 88(3): 422 – 425.

[10] XIONG M, LI M, ZHENG D, et al. Evaluation of the economic burden of leprosy among migrant and resident patients in Guangdong Province, China[J]. BMC Infect Dis, 2017, 17(1): 760.

[11] MOHD PUTERA N S, AZMAN A S, MOHD ZAIN S N, et al. Current status of infectious diseases among migrants and non-citizens in Malaysia[J]. Trop Biomed, 2023, 40(2): 138 – 151.

[12] 中国疾病预防控制中心麻风病控制中心. 全国麻风病防治管理信息系统（LEPMIS）2.0[Z/OL]. 2021. http://218.2.99.162:8081/.

[13] 周宇辉，顾恒，严良斌. 中国现代麻风防治史：1949 – 2020[M]. 南京：江苏凤凰科学技术出版社，2022.

[14] 中华人民共和国卫生部. 全国麻风病防治管理条例[Z]. 1988.

[15] SHEN Y L, KONG W M, YU M W, et al. Suspicious symptom monitoring for leprosy: an optimal practice for early detection under a low endemic situation in Zhejiang province, China[J]. Int J Dermatol, 2022, 61(12): 1532 – 1539.

[收稿日期] 2024 – 10 – 11

（编辑：黄瑛）

微信公众号